TÓM TẮT LÝ THUYẾT · TAI - MŨI - HỌNG

BÀI 6 Chấn thương thanh quản

Tóm tắt từ bài giảng 11. CT THANHQUAN.pdf (42 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. GIẢI PHẪU
3. NGUYÊN NHÂN
4. SINH BỆNH HỌC
5. LÂM SÀNG
6. CẬN LÂM SÀNG
7. PHÂN LOẠI SCHAEFER – FUHRMAN
8. ĐIỀU TRỊ
9. BIẾN CHỨNG – DI CHỨNG

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

- **Cấp cứu quan trọng** trong TMH, xu hướng **tăng** ở Việt Nam.
- **Tỷ lệ tử vong cao, chỉ sau chấn thương sọ não**.
- Chiếm **1/5.000 – 1/30.000** ca cấp cứu; người lớn **1/137.000**, trẻ em **0,5%**.

2. GIẢI PHẪU

- Thanh quản nằm từ **C4 đến C6**; giới hạn trên là **bờ trên sụn giáp**, dưới là **bờ dưới sụn nhẫn**.
- **Động mạch:** thanh quản **trên, dưới, sau**. **Thần kinh:** TK thanh quản **trên** và **dưới**.

3. NGUYÊN NHÂN

Chấn thương ngoài (External)	Chấn thương trong (Internal)
Kín (blunt): treo cổ / siết cổ, **chấn thương "dây phơi" (clothesline)**, thể thao, **tai nạn giao thông**	**Dị vật**
Hở (penetrating): dao, **hỏa khí** (mảnh đạn, đạn tốc độ thấp / cao)	**Do thầy thuốc:** nội soi, **đặt nội khí quản**
	Nhiệt: ăn uống, hít phải
	Hóa chất ăn mòn: kiềm, acid

- **Tổn thương phối hợp (ATLS):** vết thương cổ hở **18%**, **gãy xương hàm mặt 18%**, **chấn thương nội sọ 17%**, **gãy cột sống cổ 13%**, chấn thương ngực 13%, mặt khác 10%, vỡ sọ 7%, vết thương họng hở 4%.

4. SINH BỆNH HỌC

- Thanh quản tổn thương khi lực tác động vào cổ trước **ép ngược chiều về phía cột sống**.
- Ảnh hưởng bởi **quá trình vôi hóa (sau 30 tuổi)**; **nam > nữ**.

5. LÂM SÀNG

Chấn thương hở: khó thở thanh quản, **khàn / mất tiếng**, **tràn khí dưới da**; khám cổ **chỉ có giá trị trong những giờ đầu**; có thể thấy đường vào tới thanh quản.

Khó thở thanh quản: khó thở chậm, thì hít vào, **rít thì thở vào**, thay đổi tiếng nói, khóc, ho; co lõm **hõm ức, liên sườn**, tím tái khi thiếu oxy nặng; **3 độ**. Lưu ý: **trẻ nhỏ giai đoạn cuối** khó thở **nhanh, cả 2 thì**.

Chấn thương kín:

- **Khó thở có thể đến muộn** sau vài giờ đến nhiều giờ.

- **Khàn tiếng là dấu hiệu gợi ý quan trọng**; nuốt đau.
- Ho thay đổi tiếng, **khạc đờm lẫn máu** (có thể muộn).
- Khám cổ: vết trầy, bầm tím, **tràn khí dưới da**, dấu hiệu tổn thương mạch máu.

Chấn thương trong do bỏng (ngõ tiêu hóa): khó nuốt, đau họng, choáng, khó nói, ho, khạc nhầy mủ; niêm mạc miệng họng bỏng, nặng → loét, **hoại tử sụn**. **Tử vong do phù nề, co thắt thanh quản**; khỏi để lại **sẹo hẹp**.

Ngõ hô hấp: hơi nóng gây bỏng niêm mạc, nghẹt thở; **hơi độc (Clor, chất độc chiến tranh)** có thể tối cấp hoặc cấp (ho khan, khàn tiếng, khó thở, khạc đàm lẫn tổ chức hoại tử).

Tóm tắt chẩn đoán: triệu chứng – **khàn tiếng, đau, khó thở, khó nuốt**; dấu hiệu – **thở rít**, ho ra máu, **tràn khí dưới da**, **ấn đau thanh quản**, **mất gờ sụn giáp**, **dây thanh bất động**, tụ máu, phù nề, rách niêm mạc.

6. CẬN LÂM SÀNG

- **Nội soi thanh quản:** hình thái, **vận động** (liệt, hạn chế, bất thường – chú ý rung mép trước dây thanh), **sự thông thoáng đường thở**.
  - **Nội soi mũi ống mềm:** họng mũi, họng miệng.
  - **Nội soi thực quản ống cứng:** hạ họng, thực quản – **chỉ sau khi loại trừ chấn thương tủy cổ**.
- **X-quang** ngực, cổ thẳng, nghiêng: **khí quanh khí quản, trung thất, lồng ngực** – dấu đầu tiên gợi ý **tràn khí**.
- **CT scan:** chấn thương thanh quản cấp (vôi hóa, mô mềm); **tắc nghẽn đường thở cần can thiệp**; nội soi bất thường; kiểm chứng nội soi.
- **Chụp mạch đồ:** vết thương **xuyên thấu cổ**, nhất là **Zone I và Zone III**; **tiêu chuẩn vàng** đánh giá tổn thương mạch (nhạy, đặc hiệu **> 90%**), dùng cả để **thuyên tắc can thiệp**.

7. PHÂN LOẠI SCHAEFER – FUHRMAN

Nhóm	Tổn thương
I	Tụ máu, rách **nhỏ** trong thanh quản; **không gãy**
II	Phù nề, tụ máu, rách niêm mạc nhỏ **không lộ sụn**; **gãy không di lệch**; tắc nghẽn đường thở mức độ khác nhau
III	**Phù nề lớn**, rách niêm mạc lớn, **lộ sụn**; **gãy di lệch**; **dây thanh bất động**
IV	Như III nhưng nặng hơn: rách niêm mạc nặng, **tổn thương mép trước**, **gãy không vững, ≥ 2 đường gãy**
V	**Đứt rời hoàn toàn thanh – khí quản**

8. ĐIỀU TRỊ

Xử trí cấp cứu

- **Đa chấn thương: thiết lập đường thở**, hồi sức tim, kiểm soát chảy máu, **cố định cột sống**.
- **Người lớn: mở khí quản dưới gây tê tại chỗ** hoặc **đặt ống qua nội soi phế quản ống cứng**; đặt nội khí quản chỉ khi **người có kinh nghiệm** và **ống nhỏ**.
- **Trẻ em: đặt ống qua nội soi phế quản ống cứng rồi mở khí quản**.

Phác đồ: nghi ngờ → hỏi bệnh, khám.

- **Dọa tắc đường thở** → **mở khí quản** → CT → nội soi thanh quản, phế quản, thực quản.
- **Đường thở ổn** → **nội soi mũi ống mềm**: bình thường → **bảo tồn**; bất thường → CT: không chèn ép đường thở, khung sụn vững → bảo tồn (nội soi theo dõi); có chèn ép → mở khí quản.

- **Đứt sụn nhẫn – khí quản** → cắt lọc, **nối tận – tận**. Gãy không vững, tổn thương niêm mạc lớn → **nắn chỉnh cố định (ORIF)**, mở sụn giáp, đặt **stent**.

Bảo tồn – chỉ định: **nhóm I, II**; không hoặc tổn thương tối thiểu qua nội soi, **khung sụn vững trên CT**.

- **Nghỉ nói**, **steroid toàn thân**, **nằm đầu cao**, **khí ẩm**, **kháng sinh**, **chống trào ngược**.

Phẫu thuật (chấn thương ngoài):

- **Chỉ thép, nẹp vít** (tự tiêu / không tự tiêu): giữ vững cố định; **nẹp tự tiêu tiêu trong 1 – 2 năm**.
- **Mảnh ghép:** che phủ sụn lộ để tránh sẹo lớn; **niêm mạc là phù hợp nhất** (giống biểu mô thanh quản).
- **Stent:** khung sụn **gãy vụn**; ngăn **dải xơ mép trước** khi **mất biểu mô dây thanh đối xứng 2 bên**.

Chấn thương trong:

- **Do đặt nội khí quản:** phức tạp, kéo dài, **dễ tái phát** (nhất là kèm chấn thương khí quản); cắt màng, khối xơ sẹo, chỉnh hình, **ống nong**; corticoid chống sẹo xơ.
- **Do bỏng nhiệt, hóa chất: theo dõi đường thở sát ít nhất 24 giờ đầu**; **chống choáng** (dịch ngọt ưu trương), **chống đau**, **chống khó thở** (oxy, **mở khí quản**), **chống sẹo hẹp** (**stent nong thanh quản**).

9. BIẾN CHỨNG – DI CHỨNG

- **Tức thời: nghẹt thở**, **chảy máu**.
- **Thứ phát: viêm tấy lan tỏa** → **viêm trung thất**, **viêm khớp nhẫn phễu**; **hẹp thanh quản**.
- **Di chứng: rối loạn phát âm** (có thể muộn, khó hồi phục), khó thở; bỏng hóa chất / nhiệt gây **chít hẹp đường thở kéo dài 16 – 25 năm** (Casper JK).
- Nguyên tắc: **chẩn đoán sớm**, phác đồ phù hợp để **bảo tồn tối đa chức năng thanh quản**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 11. CT THANHQUAN.pdf khi cần chi tiết.